



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : جيهان محمد سمير احمد

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : شبرا الخيمة اول العنوان : =

رقم البطاقة : 28009230103987 رقم التليفون : 01003853918 تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 23-09-1980 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولاديكس قسم العلاج : الاورام [14165]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: جيهان محمد سمير احمد National ID: 28009230103987	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة هوية شخصية

جيهان
محمد سمير احمد محمد الشايب
١٩ - خورصى حنظل الروضة
مصر القديمة - القاهرة

٢٨٠٠٩٢٣٠١٠٣٩٨٧

LC6030613

٢٠٢٥/٠٥ ٢٨٠٠٩٢٣٠١٠٣٩٨٧
حاصلة على ليسانس ادب
تدرة الجزيرة
انثى مسلمة
سيد احمد احمد عزام
الطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٥/٠٢

متروجة

١



National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل بالولادى للمبادرة القومية لصحة المرأة

Pathology Report

Name: جيهان محمد سمير احمد
Clinical data: Left breast mass.
Specimen type: Tru-cut biopsy.
Date (Received): 29/6/2021
Lab. Number: 1382 / 21

Age : 40 years.

Date (reported): 25 / 7 / 2021

Hospital Number: ٥١٢٣٤٥٦٧

Gross Examination:

- Procedure: tru cut biopsy
- Localization: Lt
- Immunohistochemistry technique: Sections prepared from paraffin blocks & stained using Bench-Mark UL TRA system for ER, PR, Her-2 and Ki67
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her-2 clone (4B5), & Anti-K-67 (30-9)

Microscope examination:

- Histological type: IDC
- Grade II

Diagnosis:

Lt breast cancer, slide revision:

- Invasive duct carcinoma GII
- Biomarkers:
 - ER: strong Intensity 90% nuclear reaction (Allred score 8/8)
 - PR: strong Intensity 10% nuclear reaction (Allred score 4/8)
 - Her2: faint Intensity 10% membrane reaction (score 2+).
 - Her2 (SISH): Amplified (Her2/C117 ratio >2 & Her2 copy number >4), clon group I.
 - Ki67: 50% nuclear reaction.

Prof. Amal Hareedy
Dr. Rana Fathy

Name: جيهان محمد سمير احمد		
MR. : 8269		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 40-year-old who underwent right hemithyroidectomy for a multinodular goiter, followed by a diagnosis of triple-negative breast cancer (TNBC) that was ER-negative, PR-negative, HER2-positive. Initial treatment consisted of left breast-conserving surgery (BCS) in August 2021 with pathology revealing T2N0 disease, positive margins, and HER2 positivity. The patient subsequently underwent left modified radical mastectomy (MRM) in September 2021. Adjuvant therapy included FEC chemotherapy, radiation therapy, trastuzumab, subcutaneous HERCEPTIN, placement of a port, and endocrine therapy with ARAMIDEX, ZOLADEX, and ZOMETA. The most recent ZOMETA infusion was administered on 31-January-2026, and ZOLADEX was given on the day of the note, together with ARAMIDEX and supportive care. The patient has been on a three-month pause with a planned chest CT follow-up. A chest CT performed in April 2026 demonstrated a small sliding hiatal hernia. The patient continues on ARAMIDEX and supportive measures, and the next clinic visit is scheduled for 8 September 2026.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	اسماء محمد مصطفى نصر	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Pathology Report

Name: جيهان محمد اسمر احمد محمد

Age: 41 years.

Clinical data: multiple breast masses

Specimen type: Quadrantectomy & SLN

Date (Received): 1/8/2021.

Date (reported): 7/8/2021

Lab. Number: 1632/ 21

Hospital Number: 2563/21

Gross Examination:

- Procedure: Quadrantectomy & SLN
- Localization: Lt
- Tumor extent
 - Number: four masses at (12, 9, 6 & 6) O'clock
 - Size: up to 2.2x1.5cm
 - Skin involvement: no covering skin
- Distance from margins: 0.1cm last resection margin
- Lymph nodes number and size: 6 nodules up to 2x1cm

Microscope examination:

- Histological type: malignant [IDC] GII
- Ductal carcinoma in situ: Extensive
- Lymph node involvement: 0/6
- Resection Margins: involved by extensive DCIS

Diagnosis:

- Lt multiple breast masses, Lt Quadrantectomy:
 - Multicentric IDC, with DCIS.
 - Positive margin at 6 & 9 O'clock (involved by DCIS).
 - Free other margins.
 - Lymph nodes free 0/6
 - Stage pT2m pN0

Prof. Amal Hureedy
Dr. Rana Fathy

Patient Name :
Patient No : 28009230103987
Path No. : 1963
Sex : Female
Age : 41 Y
Referring Doc :

Request No. : 131712
Request Date : 02/09/2021
Verification Date : 19/09/2021
Financial Category :
Department : Out Patient

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer

Nature of the specimen: Left completion mastectomy and axillary clearance.

Gross Examination: Two specimen were received and designated as: (1) Left MRM, measure 26x20x5cm, skin covering 27x13 cm, nipple, was unremarkable. (2) Axillary lymph node, fibrofatty tissue measure 2.5x2 cm

• Procedure: Completion Mastectomy

• Localization: Left

• Tumor extent: tumor bed site

o Number: one

o Size: 2.5x2 cm

o Skin involvement:

• Distance from margins: 1cm, from deep margin

• Lymph nodes number and size: 5 LNs, up to 1 cm in diameter

• Additional pathologic findings: No

• Frozen section: Involved margin by DCIS (Left WLE)

Microscopic examination:

• Histological type: ductal carcinoma insitu

• Ductal carcinoma in situ: Yes

• Lymph node involvement: partial metastatic deposits in two lymph nodes (2/5)

• Resection Margins: free deep margin

o Free /DCIS/ invasive carcinoma

Diagnosis:

Left completion mastectomy and axillary clearance:

• Residual multicentric ductal carcinoma insitu, reaching the main lactiferous duct beneath the nipple, with resection site changes.

• Partial metastatic deposits in two lymph nodes with no extracapsular extension (N1a)

• For completion with previous pathology report.

Prof. Dr. Amal Hareedy

Printing Date: 21/09/2021 12:45:38

Page 1 of 2

Dr. Mona Mohamed

Printing By: thermal

Patient Name: Jihan Mohamed Samir Ahmed Mohamed Al Shayeb	Date : 22/08/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 44 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 20198

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

No previous studies available for comparison at time of reporting

1. Chest:

- Status post left MRM with tissue expander.
- No sizable pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with no focal lesions on non contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Left adnexal small cystic lesion mostly functional.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- No destructive lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- Status post left mastectomy.
- No definite hepatic or pulmonary metastatic deposits on non contrast basis.

Dr. Wafaa Ali, MSc.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.

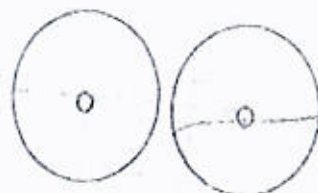


0.1100
0.1100

all data on...

MDT FORM 11

<u>Name</u>	1-23 N 5-10
<u>Age</u>	40
<u>MRN</u>	5-A-97.1-9901
<u>ID</u>	1-2909917
<u>Co</u>	1-51/107P
<u>morbidity</u>	



2h 55/

- 4 m 12 cm

Clinical Data

Clinical Data	
PX:	SM:
IHC:	metastatic
ER: 2/8	Met's Workup:
PR: 4/8	et → free
Hert: 21 → Amputated	
KITV: 5/22	
PT₂ N M 1 m 2/11 (Bone scan wait) RT BCLT. LEN → PT₂ m. 1 No/o 1 7/8/21 the margin LI mrm. → Residual malignant Ducts 13/9/2021 + 1 NO/5 MDT OUTCOME & PLAN	

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

For Adjuvant chemotherapy

AC X 4 → Taxol X Herceptin X 4

→ PORT → AI & Zoladex

1911

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
1911	1911	1911	